Nombre: _____

Fecha: _____

AIP proyectado y observado

Las partes A y B usan ejemplos ilustrativos del Estado de Luvina. La parte C y la pregunta d2 usan estudios publicados. Escriba o elija su respuesta y compare con su facilitador.

Parte A. Dos errores que se compensan

El AIP de un tratamiento T en el Instituto de Salud del Estado (ISES) de Luvina proyectó, para el año 2, 500 pacientes a MXN 40,000 por paciente. Se observaron 650 pacientes y un costo pagado de MXN 30,000 por paciente.

1. Gasto proyectado del año 2

Respuesta: _____ MXN

2. Gasto observado del año 2

Respuesta: _____ MXN

3. Gasto con los pacientes observados y el precio proyectado

Respuesta: _____ MXN

4. ¿Cómo se lee este caso?

- ☐ El AIP acertó, porque el gasto observado casi coincide con el proyectado.
- ☐ El AIP subestimó el número de pacientes y sobreestimó el precio; los dos errores casi se compensaron.
- ☐ El AIP sobreestimó el número de pacientes.

Parte B. La adopción

El AIP de un tratamiento T en la SSAL supuso una adopción de 60% de 1,000 pacientes elegibles en el año 1. Con los datos de dispensación, se observaron 150 pacientes con T.

5. Pacientes con T proyectados en el año 1

Respuesta: _____ pacientes

6. ¿Cuántas veces superó la proyección a lo observado?

Respuesta: _____ veces

7. ¿Qué pregunta conviene hacer sobre la adopción supuesta en un AIP para el sector público mexicano?

- ☐ ¿Las licitaciones y los tiempos de entrega pueden retrasar la adopción supuesta?
- ☐ ¿El fabricante tiene experiencia en otros países?
- ☐ ¿El precio está en dólares?

Parte C. El caso de los antirretrovirales en México

Datos publicados: Chaumont 2015 partió de 53,357 pacientes en tratamiento en septiembre de 2013 y proyectó entre 72,149 y 87,972 pacientes del Seguro Popular a junio de 2018. Censida reporta 85,838 personas en tratamiento en los servicios especializados de la Secretaría de Salud al 30 de junio de 2017.

8. ¿Cuántas personas más que en septiembre de 2013 reporta Censida a junio de 2017?

Respuesta: _____ personas

9. ¿Dónde queda el dato de Censida frente al rango proyectado?

- ☐ Por debajo del piso de 72,149.
- ☐ Dentro del rango, cerca del techo de 87,972, y 1 año antes del horizonte.
- ☐ Por encima del techo.

10. ¿Por qué esta comparación es aproximada?

- ☐ Porque el estudio cuenta afiliados al Seguro Popular y Censida cuenta personas atendidas en los servicios de la Secretaría de Salud, con 1 año de diferencia.
- ☐ Porque Censida no es una fuente oficial.
- ☐ Porque el estudio no proyectó un número de pacientes.

Parte D. Verdadero o falso

11. Un impacto observado mayor que el proyectado puede comprometer la continuidad del acceso a la tecnología.

☐ Verdadero ☐ Falso

12. En Países Bajos, el impacto real de los antivirales para hepatitis C quedó por debajo de todas las estimaciones de los expedientes de reembolso.

☐ Verdadero ☐ Falso

Diplomado en Economía de la Salud y Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Pulso. La explicación completa está en la página de la unidad U32.